

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-02 至 2026-06-08。每篇文章单独成页，按“标题、结论、主要内容、关键信息、启示”快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库	PDAT 发表日期	MDAT 记录更新	精选入页
37	22	199	5

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

下载 PDF 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-08 检索；窗口为 2026-06-02 至 2026-06-08，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。本日按最新规则纳入 5 篇，排除 pubmed-history.json 中既往日期已覆盖 PMID；未纳入 review，因此本期无需要贴全文 figure/chart 的综述页。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	真实世界 / 一线治疗强度	新诊断 DLBCL	42251703	治疗强度、疾病负担与新诊断 DLBCL 生存：城市学术中心真实世界研究	打开文献
2	ADC / 随机 III 期 长期随访	既往未治疗 DLBCL	40991874	POLARIX 五年随访：Pola-R-CHP 对比 R-CHOP 一线治疗 DLBCL	打开文献
3	CAR-T / 全国真实世界登记	R/R LBCL	41544566	日本全国登记：tisa-cel 治疗 R/R LBCL 的真实世界结局	打开文献
4	BTKi / PCNSL 安全性病例系列	PCNSL	41621897	PCNSL 中 tirabrutinib 相关皮肤不良事件：发生率与处理	打开文献
5	机制与转化 / 蛋白基因组分型	DLBCL	42242231	DLBCL proteogenotype：478 例肿瘤的蛋白组、转录组与基因组整合	打开文献

治疗强度、疾病负担与新诊断 DLBCL 生存：城市学术中心真实世界研究

PMID 42251703

打开 PubMed 文献

Treatment intensity, illness burden, and disparities in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma treated at an urban academic center.

真实世界 / 一线治疗强度

新诊断 DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中，2026-06-07 新发表/新入库；本日高临床相关条目

P

城市学术中心新诊断 DLBCL 患者

I

较低或较高蒽环/环磷酰胺相对剂量强度的一线治疗实践

C

ARDI <0.9 vs 较高 ARDI，并按 PS、CCI、DEL 等因素调整

O

PFS、OS、疾病进展、非复发死亡、治疗耐受性

结论

344 例新诊断 DLBCL 的真实世界研究显示，较低蒽环/环磷酰胺相对剂量强度与更差 PFS、OS、疾病进展和非复发死亡相关，但低剂量本身也受到疾病负担、体能状态和治疗耐受性的混杂影响。

主要内容

- 摘要要点：研究评估治疗强度、疾病负担和社会经济因素对 DLBCL 生存的影响，强调低剂量强度常与更高毒性风险和基础疾病负担并存。
- 对象为城市学术癌症中心 344 例 DLBCL；55% 接受较低强度治疗，定义为环磷酰胺和多柔比星平均相对剂量强度 ARDI <0.9。
- ARDI、体能状态、Charlson 合并症指数和 double expressor lymphoma 与 PFS/OS 相关。
- 低 ARDI 与较差 PFS (HR 2.59) 和 OS (HR 4.26) 相关，并与进展风险和非复发死亡风险升高相关。

关键信息

- 作者：Hua-Jay J Cherng、David DeStephano、Patrick Gould、David Sabatino、Alexander D Sanjurjo、Brian Cuzzo 等。
- 研究设计：单中心回顾性真实世界研究；不是随机剂量强度干预试验。
- 核心限制：低 ARDI 可能反映基线脆弱性、治疗不耐受和高危疾病，而不只是治疗不足。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认样本量、低 ARDI 定义、PFS/OS HR、进展风险、非复发死亡风险和多学科综合照护结论。

论文作者观点

论文作者观点：需要综合多学科照护来降低 DLBCL 治疗不足相关风险。

我的推断

我的推断：一线 DLBCL 方案设计和真实世界登记应固定记录 ARDI、PS、合并症、DEL、毒性停减量和非复发死亡，避免只用“是否足量化疗”解释结局。

POLARIX 五年随访：Pola-R-CHP 对比 R-CHOP 一线治疗 DLBCL

Five-Year Outcomes of the POLARIX Study Comparing Pola-R-CHP and R-CHOP in Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma.

ADC / 随机 III 期长期随访

既往未治疗 DLBCL

MDAT 命中，近 7 天记录更新；高相关长期证据补充，非本周新发表

P

既往未治疗、中高危 DLBCL 患者

I

Pola-R-CHP

C

R-CHOP

O

五年 PFS、OS、淋巴瘤相关死亡、高危亚组结果、长期耐受性

结论

POLARIX 五年更新显示，Pola-R-CHP 较 R-CHOP 维持 PFS 获益 (HR 0.77) ，五年 PFS 为 64.9% vs 59.1%；OS 趋势改善但未达到统计学显著，长期耐受性相似。

主要内容

- 摘要要点：这是一线 DLBCL ADC 联合方案的长期随机证据更新，重点是 PFS 获益是否能在五年随访中保持。
- 全球 ITT 人群 N=879，中位随访 64.1 个月；比较 Pola-R-CHP 与 R-CHOP。
- 五年 PFS: 64.9% vs 59.1%，HR 0.77；OS HR 0.85，未达到统计学显著。
- 探索性分析提示 Pola-R-CHP 在 ABC-DLBCL 和 IPI 3-5 等高危亚组中五年生存率更有利，长期耐受性相似。

关键信息

- 作者：Franck Morschhauser、Gilles Salles、Laurie H Sehn、Alex F Herrera、Jonathan W Friedberg、Marek Trněný 等。
- 研究类型：多中心、随机对照、III 期长期随访。
- 关键信息：PFS 获益持续，但 OS 仍需谨慎表述；适合放在一线方案排序和高危分层讨论中。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 POLARIX、NCT03274492、N=879、中位随访 64.1 个月、PFS HR、五年 PFS、OS HR 和长期耐受性。

论文作者观点

论文作者观点：Pola-R-CHP 代表 DLBCL 一线治疗标准选择之一。

我的推断

我的推断：一线 DLBCL 方案设计应把高危亚组、PFS 持续性、OS 未显著和后续治疗影响分开讨论，不能把 PFS 获益直接等同为所有患者 OS 获益。

日本全国登记：tisa-cel 治疗 R/R LBCL 的真实世界结局

Real-world outcomes of tisagenlecleucel treatment in patients with relapsed or refractory large B-cell lymphomas: a nationwide registry.

PMID 41544566

打开 PubMed 文献

CAR-T / 全国真实世界登记

R/R LBCL

MDAT 命中，近 7 天记录更新；CAR-T 高相关真实世界补充

P 接受 tisa-cel 的 R/R LBCL 患者

I tisagenlecleucel CAR-T 治疗

C 按基线 KPS、移植史、结外病灶、ALC、LDH、年龄和采集至输注时间分层

O 1 年 PFS、1 年 OS、CRS、ICANS、结局预测因素

结论

日本 489 例 LBCL 全国登记显示，tisa-cel 真实世界 1 年 PFS 为 43.2%、OS 为 65.9%，CRS 发生率 71%、ICANS 5%，并提示 KPS、移植史、结外病灶、ALC、LDH 等输注前因素影响结局。

主要内容

- 摘要要点：研究提供日本最大 tisa-cel LBCL 真实世界数据，用于检验临床试验结果在常规实践中的可重复性。
- 纳入 489 例接受 tisagenlecleucel 的 LBCL 患者；中位年龄 62 岁，89% 已接受 ≥3 线既往治疗。
- 输注时 22% 已处于 CR；估计 1 年 PFS 43.2%，1 年 OS 65.9%。
- 多变量分析提示较好 KPS、既往干细胞移植史、无结外病灶、较高 ALC、较低 LDH 与更好 PFS/OS 相关。

关键信息

- 作者：Masatoshi Sakurai、Yasuyuki Arai、Hideki Goto、Haryoon Kim、Kyoko Masuda、Toshio Kitawaki 等。
- 安全性：CRS 71%，ICANS 5%；摘要称早期安全性与既往试验一致。
- 研究限制：回顾性登记研究，可能受转诊、生产周期、桥接治疗和输注前状态影响。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认全国登记、489 例、1 年 PFS/OS、CRS/ICANS、KPS/ALC/LDH/结外病灶等预测因素。

论文作者观点

论文作者观点：该研究提供最大的 tisa-cel LBCL 真实世界数据，结果与既往试验总体一致。

我的推断

我的推断：CAR-T 日更应把输注前疾病状态、等待时间、ALC/LDH、结外病灶和 CRS/ICANS 与疗效并列记录，而不是只看 ORR 或 CR。

PCNSL 中 tirabrutinib 相关皮肤不良事件：发生率与处理

Incidence and Management of Tirabrutinib-associated Cutaneous Adverse Events: A Case Series.

PMID 41621897

打开 PubMed 文献

BTkI / PCNSL 安全性病例系列 PCNSL MDAT 命中, 近 7 天记录更新: CNSL/BTKi 安全性高相关补充

P 接受 tirabrutinib 的 PCNSL 患者

I tirabrutinib 治疗期间的皮肤 AE 监测与处理

C 不同皮肤 AE 类型、起病时间和处理方式的病例比较；无随机对照

O 皮肤 AE 发生率、CTCAE 分级、起病时间、处理、停药

结论

单中心 PCNSL 病例系列显示, tirabrutinib 相关皮肤不良事件较常见 (5/7, 71.4%) , 多数在 1 个月内出现且可处理, 但 1 例因严重皮肤不良事件停药。

主要内容

- 摘要要点: 研究关注 PCNSL 使用 tirabrutinib 后的真实世界皮肤毒性, 而不是抗肿瘤疗效。
- 纳入 2020-03-01 至 2024-02-29 接受 tirabrutinib 的 7 例 PCNSL 患者, 按 CTCAE v5.0 评估皮肤事件。
- 5 例出现皮肤障碍: 3 例 2 级斑丘疹、1 例 3 级多形红斑、1 例 2 级湿疹样病变。
- 中位起病 22.4 天, 4 例在 1 个月内发生; 处理包括口服抗组胺药和外用糖皮质激素。

关键信息

- 作者: Satoru Matsunuma、Harutaka Seshimo、Shigeki Sunaga、Kunitoshi Otsuka、Toru Koshiishi、Koichi Yoshimoto 等。
- 安全性记忆点: 71.4% 出现皮肤事件, 1 例因严重事件停用 tirabrutinib。
- 研究限制: 7 例单中心病例系列, 不能估计稳定人群风险, 也不能直接比较不同 BTkI。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要确认 PCNSL、tirabrutinib、样本量 7、皮肤 AE 类型、CTCAE 分级、起病时间、处理方式和停药病例。

论文作者观点

论文作者观点: tirabrutinib 相关皮肤不良事件常见但多数可管理, 早期监测很关键, 需更大规模研究评估风险因素和预防策略。

我的推断

我的推断: PCNSL/BTKi 研究和真实世界表单位应把皮肤毒性起病时间、分级、处理、停药和再挑战单独记录, 尤其适用于老年 PCNSL 人群。

DLBCL proteogenotype: 478 例肿瘤的蛋白组、转录组与基因组整合

Pathogenesis of diffuse large B cell lymphoma proteogenotypes.

PMID 42242231

打开 PubMed 文献

机制与转化 / 蛋白基因组分型 DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 命中, 2026-06-04 新发表/新入库; 高影响力转化研究

P 478 例 DLBCL 肿瘤及其多组学数据

I 蛋白组、转录组、基因组、单细胞和空间转录组整合分型

C 7 个 proteogenotype 之间, 以及 PG4 与既有 COO/IPI/遗传分型的比较

O 高危分型、结局关联、MYC/TCF3/4 活性、BTG1 突变、CD8 T 细胞耗竭微环境

结论

Cancer Cell 研究整合 478 例 DLBCL 肿瘤的蛋白组、转录组和基因组, 提出 7 类 proteogenotype; 其中 PG4 独立于 COO、IPI 和遗传特征提示较差结局, 并呈 MYC/TCF3/4 活性增强及 CD8 T 细胞耗竭微环境。

主要内容

- 摘要要点: 研究试图用蛋白组整合基因组/转录组, 解释 DLBCL 现有分型之外的高危异质性。
- 整合 478 例 DLBCL 肿瘤数据, 识别 7 个 proteogenotype, 跨越既有分子亚型。
- PG4 与较差结局相关, 且独立于 cell-of-origin、IPI 和遗传特征; 包含 ABC、GCB 和遗传未分类病例。
- 单细胞测序和空间转录组显示 PG4 中 MYC 与 TCF3/4 转录活性增强, 且微环境表现为耗竭 CD8+ T 细胞。

关键信息

- 作者: Julius C Enssle、Björn Häupl、Arber Qoku、Boya Wang、George W Wright、Sharon Barrans 等。
- 关键信息: PG4 共享 dark-zone-related B cell phenotype, 并富集可激活 MYC 的 BTG1 突变。
- 研究定位: 高影响力转化研究, 不是临床治疗试验; 启示在于诊断分层和靶点假设。

启示

已验证证据
已验证证据: PubMed 摘要确认 478 例、7 个 proteogenotype、PG4 独立高危、BTG1/MYC、单细胞/空间组学和 CD8 T 细胞耗竭微环境。

论文作者观点
论文作者观点: 该研究为未来 DLBCL 诊断和治疗策略提供 proteogenomic 框架。

我的推断
我的推断: DLBCL 后续方案设计可考虑把 proteogenotype、MYC 活性、TME 耗竭状态与 Pola-R-CHP、CAR-T、双抗等治疗结局做交叉分析, 但目前不能把 PG4 直接作为临床选药依据。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 201 条，排除历史 PMID 后精选 5 篇，覆盖 DLBCL 一线治疗强度、Pola-R-CHP 长期随机证据、CAR-T 真实世界、PCNSL tirabrutinib 安全性和 DLBCL proteogenotype 转化分型。	论文作者观点 入选论文作者共同强调的方向是：DLBCL 治疗需要同时考虑强度、分层和长期随访；CAR-T 真实世界需关注输注前状态和毒性；PCNSL/BTKi 安全性需要早期监测；proteogenomic 分型为后续诊断和治疗假设提供框架。	我的推断 我的推断是，后续每日监测应继续优先选择能影响方案设计、分层变量、毒性管理或转化假设的研究；泛癌、诊断偶发、动物或过低相关条目不应只为凑数进入正文。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。